

Dương vật bị vùi mắc phải là tình trạng dương vật **bị ẩn dưới da và mỡ** ở bụng dưới, bìu hoặc đùi ở người trưởng thành. Tình trạng này có thể gây khó vệ sinh, nhiễm trùng da tái phát, khó tiểu đứng và ảnh hưởng đến quan hệ tình dục. Đây là vấn đề tái tạo đã được ghi nhận và có thể điều trị — phẫu thuật có thể giải phóng và phục hồi dương vật.

Về tình trạng này

“Mắc phải” có nghĩa là tình trạng phát triển ở tuổi trưởng thành (khác với dương vật bị vùi lành tính ở trẻ em). Các nguyên nhân thường gặp gồm: **tăng cân** và khối mỡ bụng dưới lớn, sẹo từ cắt bao quy đầu hoặc phẫu thuật trước đây, phù bạch huyết mãn tính (**lymphedema**), và bệnh da gây sẹo gọi là **lichen sclerosus**.

Tình trạng này thường tạo ra vòng luẩn quẩn khó phá vỡ:

- Da bị kẹt ẩm ướt, dễ bị **viêm và nhiễm trùng**.
- Nước tiểu bắn vào da bị kẹt làm nặng thêm tình trạng kích ứng và sẹo.
- Vệ sinh, đi tiểu và quan hệ tình dục ngày càng khó khăn hơn.

Tại sao cần phẫu thuật sửa chữa

Phẫu thuật nhằm **giải phóng dương vật**, loại bỏ da bệnh và tái tạo lớp che phủ lành mạnh để bạn có thể tiểu đứng, giữ vệ sinh và trở lại sinh hoạt bình thường — mức độ hài lòng sau phẫu thuật thường cao.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Dương vật bị vùi (ẩn)

Dương vật bị che khuất dưới da và mỡ xung quanh.

Panniculectomy

Cắt bỏ tạp dư mỡ/da bụng dưới chầy xệ.

Escutcheonectomy

Cắt bỏ khối mỡ phía trên dương vật.

Ghép da (skin graft)

Da lành được chuyển đến để che phủ thân dương vật.

Lichen sclerosus

Bệnh da gây sẹo, có thể gây ra hoặc làm nặng thêm tình trạng này.

Lymphedema

Phù bạch huyết mãn tính có thể vùi dương vật.

TÔI CÓ CẦN GIẢM CÂN TRƯỚC KHÔNG? Thường là có — với dương vật bị vùi do thừa cân, giảm cân (đôi khi được chuyển đến bác sĩ phẫu thuật béo phì) giúp cải thiện kết quả và độ bền lâu dài, vì vậy nhóm chăm sóc có thể khuyên thực hiện trước hoặc song song với phẫu thuật. Bản thân phẫu thuật thường **loại bỏ khối mỡ lớn** cùng một lúc.

Cách tiến hành phẫu thuật

- 1 Dương vật được **giải phóng** khỏi sẹo và mô đang kẹp chặt nó.
- 2 Da bệnh hoặc da có sẹo được cắt bỏ; thân dương vật thường được tái tạo bề mặt bằng **ghép da**.
- 3 Khối mỡ/tạp dễ chảy xệ được cắt bỏ (**panniculectomy / escutcheonectomy**); bìu có thể được tạo hình lại.
- 4 Đôi khi thực hiện theo **nhiều giai đoạn**; ống thông tiểu được đặt và dẫn lưu là phổ biến.

Cách chuẩn bị

- **Tối ưu hóa cân nặng** (có thể chuyển đến bác sĩ phẫu thuật béo phì) và **ngưng hút thuốc** — cả hai đều ảnh hưởng mạnh đến quá trình lành thương.
- Điều trị triệt để mọi nhiễm trùng da đang hoạt động; tuân thủ hướng dẫn gây mê/gây tê.
- Sắp xếp người hỗ trợ tại nhà và nghỉ phép đủ thời gian — quá trình hồi phục cần nhiều công chăm sóc.

Sau phẫu thuật

- Cần **nằm viện**, đặt ống thông tiểu và dẫn lưu trong một thời gian.
- Nếu có ghép da, hãy **bảo vệ mảnh ghép** — tránh ngồi/đề lên vùng đó theo hướng dẫn.
- Chăm sóc vết thương và phục hồi hoạt động từ từ; kiểm soát cân nặng giúp duy trì kết quả lâu dài.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt, đỏ lan rộng hoặc dịch có mùi hôi (nhiễm trùng)
- Mảnh ghép da hoặc vết thương chuyển **màu tối**, hở miệng hoặc chảy máu nhiều
- **Không tiểu được** hoặc ống thông tiểu ngừng dẫn lưu

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Dương vật bị vùi mắc phải ẩn dương vật dưới da và mỡ, gây khó vệ sinh, tiểu khó, nhiễm trùng và ảnh hưởng tình dục — và có thể phẫu thuật sửa chữa.
2. Phẫu thuật giải phóng dương vật, cắt bỏ da bệnh (thường kèm ghép da) và loại bỏ khối mỡ lớn; có thể thực hiện nhiều giai đoạn.
3. Giảm cân và không hút thuốc giúp cải thiện kết quả rõ rệt. Gọi ngay nếu sốt, mảnh ghép tối màu hoặc khó tiểu.